

Ukryte *rytuały* w głowie

Pacjent powstrzymuje się od mycia rąk. Ale w głowie analizuje, modli się, neutralizuje. ERP nie działa.

CZAS: 15 min identyfikacji + ciągła praktyka Krytyczne dla „Pure O” i ERP, które nie działa

ŹRÓDŁO: Abramowitz i wsp. (2003); Williams i wsp. (2011); Hershfield i Corboy

JAK UŻYWAĆ

Przeprowadź **audyt sześciu typów** kompulsji mentalnych: neutralizowanie, mentalne modlenie, analizowanie („czy bym to zrobił?”), mentalne sprawdzanie, powtarzanie „bezpiecznych” słów/liczb, wewnętrzne zapewnianie. Dla każdej: *jak ją rozpoznasz* w momencie pojawienia? RP: gdy zauważysz — **przerwij w połowie** i toleruj dyskomfort.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Abramowitz i wsp. (2003): kompulsje mentalne (ang. *mental rituals*) to **główny powód „niepowodzenia” ERP**. Pacjent myśli: „*nie myję rąk — to wystarczy*”. Tymczasem w głowie analizuje, neutralizuje, modli się mentalnie, powtarza „bezpieczne” słowa. **Mózg nie odróżnia** kompulsji behawioralnej od mentalnej — efekt ten sam: *cykl OCD trwa*. Williams i wsp. (2011): pacjenci z „Pure O” reagują na ERP **równie dobrze** jak ci z kompulsjami widocznymi — ale *tylko* jeśli kompulsje mentalne włączone do RP. Klucz: **rozdzielenie** obsesja (niechciana, automatyczna) vs kompulsja mentalna (celowa próba ulgi).

01 ☞ Sześć typów kompulsji mentalnych

1 · NEUTRALIZOWANIE

Po „złej” myśli zastępujesz „dobrą”. Po obrazie krzywdy — wizualizacja dobra. **Anuluje ekspozycję**. Mózg uczy się: zła myśl wymaga neutralizacji.

2 · MENTALNE MODLITWY

Powtarzanie modlitwy w głowie po obsesji religijnej/bluźnierczej. *W kontekście wiary* — modlitwa może być duchowa albo kompulsywna. **Klucz: cel** — czy redukcja lęku?

3 · ANALIZOWANIE

„Ale czy naprawdę bym to zrobił?”, „Co to o mnie mówi?”. Godziny rozważań. Wygląda jak myślenie — **jest kompulsją**. Każda runda daje krótką ulgę.

4 · MENTALNE SPRAWDZANIE

Odtwarzanie w głowie wspomnień. „Czy na pewno wyłączyłem kuchenkę?” — i w wyobraźni cofasz się i sprawdzasz. **Jak fizyczne sprawdzanie** — tylko mentalne.

5 · POWTARZANIE „BEZPIECZNYCH” SŁÓW / LICZB

„Wszystko będzie dobrze” — 7 razy w głowie. Bezpieczna liczba. Mantra ochronna. **Liczenie w myślach** jako rytuał.

6 · WEWNĘTRZNE ZAPEWNIANIE

Sam sobie dajesz zapewnienie: „na pewno jest OK”, „nic złego się nie stanie”. Bez bliskich — w samotności. **Najtrudniejsze do wykrycia**.

02 ? Obsesja vs kompulsja mentalna — kluczowa różnica

OBSESJA

- **Niechciana** — pacjent jej nie chce
- **Automatyczna** — pojawia się sama
- Wywołuje lęk, wstręt, dyskomfort
- Pacjent *próbuje* ją odepchnąć

„Wpadła mi do głowy myśl o krzywdzeniu dziecka” — to obsesja.

KOMPULSJA MENTALNA

- **Celowa** — pacjent ją inicjuje
- **Strategia ulgi** — ma zredukować lęk
- Daje *krótkie* poczucie kontroli
- Pacjent *powtarza* ją wielokrotnie

„Teraz wyobrażę sobie, że dziecko jest bezpieczne” — to kompulsja.

Test: czy celem tej myśli/czynności jest **zredukowanie lęku**? Jeśli tak — to **kompulsja**. Niezależnie od formy.

TYP KOMPULSJI MENTALNEJ	KONKRETNY PRZYKŁAD Z MOJEGO ŻYCIA	JAK JĄ ROZPOZNAM W MOMENCIE POJAWIENIA
Neutralizowanie		
Mentalne modlitwy		
Analizowanie		
Mentalne sprawdzanie		
Powtarzanie słów/liczb		
Wewnętrzne zapewnianie		

04 RP w warstwie mentalnej — trzy kroki

1 · ZAUWAŻ MOMENT STARTU

„Zaczynam analizować”. Mózg startuje kompulsję mentalną w sekundach. **Klucz: świadomość momentu.**

2 · PRZERWIJ W POŁOWIE

Nie kończ rytuału. **Zatrzymaj się**,
choćby w środku zdania. Mózg
uczy się: kompulsja nie musi być
dokończona.

3 · TOLERUJ DYSKOMFORT

Lęk wraca z impetem. **Toleruj, nie reaguj.** Wróć do tego, co robiłeś/-aś. Każda taka tolerancja *uczy mózg*.

Pułapka: „skończę tylko tę modlitwę / analizę / liczenie — potem przestane”. *Nie*. Każde dokończenie wzmacnia cykl. Lepsze **niepełne RP** (przerwałem w 60% rytuału) niż „dokończę i przestane” (utwierdzenie cyklu).

Klucz: Abramowitz i wsp. (2003): pacjenci, u których ERP „nie działa”, w 80% przypadków mają niezidentyfikowane kompulsje mentalne. Williams i wsp. (2011): „Pure O” reaguje na ERP **równie dobrze**, gdy włączymy mentalne RP. Klucz diagnostyczny: *jeśli celem analizy / modlitwy / sprawdzenia jest zmniejszenie lęku — to kompulsja*. Niezależnie od subiektywnego poczucia, że „to przecież naturalne”. Bez RP w warstwie mentalnej postęp jest **niepełny**. Łącz z *tolerancją niepewności i defuzją* z ACT.